予想問題　第1回

総合問題

医学科

問題

愛媛大学 前期日程 対策

医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）

試験時間 120 分 ／ 200 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

問題は問題1・問題2の2題です。答えは、解答用紙の対応する欄にすべて書くこと。

字数制限のある問題は、句読点も1字に数えます。下書きには、この冊子の空いている部分を使ってよい。

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

問題1 医療・科学の英文 （配点 100 点）

以下は、ある国の保健当局が市民向けに公開した解説記事（架空）である。これを読み、問1～問6に答えよ。*印の語には本文の後に注を付した。字数を指定した問いでは、句読点やかっこも1字として数える。

Antibiotics: A Shared Resource We Are Using Up

When antibiotics were introduced in the 1940s, they changed medicine almost overnight. Infections that had once killed young, healthy people — a scratch that became infected, a case of pneumonia*, a difficult childbirth — could suddenly be cured in days. Operations such as hip replacements and cancer treatments, which leave the body open to infection, became far safer. ①It is difficult to think of a single area of modern medicine that does not depend, directly or indirectly, on these drugs.

Bacteria, however, are living things, and living things adapt. Each time an antibiotic is used, most of the bacteria it targets are killed, but a few may survive because of small differences in their genes. These survivors multiply, and their descendants inherit the same ability to resist the drug. ②In this sense, every dose of an antibiotic is also a small experiment in evolution, and the bacteria are the ones learning from it.

The more often antibiotics are used, the faster resistance spreads. A large share of prescriptions are given for illnesses that antibiotics cannot treat at all, such as colds and most sore throats, which are caused by viruses. Patients sometimes ask for antibiotics because they want to feel that something is being done, and busy doctors may agree in order to save time. ③Each of these decisions may seem harmless on its own, but together they slowly weaken a tool that belongs not to any single patient or doctor but to everyone, including people not yet born.

The consequences are already visible. In many hospitals, doctors now encounter infections that respond to only one or two remaining drugs, and occasionally to none. Developing new antibiotics is slow and expensive, and because a new drug would be kept in reserve and used as little as possible, companies have little financial reason to invest in one. ④This creates an unusual situation: the more valuable a new antibiotic is to society, the less profitable it may be to the company that makes it.

Health authorities therefore emphasize “stewardship*”: using antibiotics only when they are truly needed, choosing the right drug for the right length of time, and preventing infections in the first place through vaccination and good hygiene. Some clinics have introduced simple measures, such as rapid tests that show within minutes whether an infection is bacterial, or a policy of waiting a few days before prescribing for mild symptoms. ⑤These measures have reduced unnecessary prescriptions without harming patients, and they have shown that public understanding is as important as new technology.

---

*pneumonia 肺炎 *stewardship （資源の）適正な管理、適正使用

問1 下線部①について、抗菌薬に依存している医療の例として本文に挙げられているものを、第1段落から英語で3つ抜き出せ（1つにつき2語以上の語句でもよい）。

問2 下線部②で筆者が抗菌薬の使用を「進化の実験」と表現しているのはなぜか。60字以内（句読点も1字と数える）の日本語で説明せよ。

問3 下線部③を、本文の趣旨がわかるように、100字以内の日本語に訳せ。

問4 下線部④の「異例の状況」が生まれる理由を、本文をもとに日本語で説明せよ。

問5 下線部⑤の These measures に当たる取り組みと、その結果わかったことを、80字以内の日本語で述べよ。

問6 本文の内容をふまえ、将来医師として外来診療を行う際に、抗菌薬を求める患者に対してどのように対応したいと考えるか。患者側の事情にも触れながら、自分の考えを240字以内の日本語で述べよ。

問題2 臨床の状況と専門家の見解 （配点 100 点）

あなたは地域の診療所に勤める医師で、文章1のような場面に立ち会っている。これについて、ある医療倫理の専門家が文章2の見解を述べている（いずれも架空）。二つの文章を読み、問1～問4に答えよ。字数を指定した問いでは、句読点やかっこも1字として数える。

文章**1**

Mr. Hara, aged 84, has lived alone in a small mountain village since his wife died. He has heart failure, and over the past year he has become short of breath even when walking slowly. At today's visit, his condition has clearly worsened. You believe he would benefit from a short stay in the city hospital, about an hour away, to adjust his medicine. When you explain this, Mr. Hara shakes his head. "I know what happens to old men who go into hospital," he says. "They don't come back. I would rather stay in my own house, even if it means my life is shorter." His daughter, who lives in the city and has come with him today, takes you aside. "Please," she says quietly, "①tell him he has no choice. He listens to doctors. I can't bear the idea of him dying alone up there."

文章**2**

In situations like this, doctors often feel caught between two duties: to protect the patient's health and to respect the patient's wishes. It can be tempting to settle the conflict by using the authority that patients and families give to doctors. ②But a decision obtained through pressure is not truly the patient's decision, even if it turns out well medically.

Respecting autonomy does not mean simply accepting the first answer a patient gives. Mr. Hara's refusal is based partly on a fear — that hospital means the end — which may not be accurate. The doctor's first task is to understand what lies behind the words: what he values, what he fears, and what he knows. Perhaps the stay could be shorter than he imagines, or a nurse could visit him at home instead. ③Good care often begins not with a recommendation but with a question.

The daughter's request also deserves attention, but it should be understood as an expression of love and anxiety rather than as an instruction. Families can be involved in the conversation, yet the final choice of a patient who is able to decide belongs to the patient. If, after careful discussion, Mr. Hara still chooses to stay at home, the doctor's role is not finished. ④It shifts from persuading him to supporting him, so that the life he has chosen can be lived as safely and comfortably as possible.

問1 次の文は、文章2の考え方を医学生がまとめたものである。空所 (a)～(e) に補うのにふさわしい語を、下の語群からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えよ。各語は一度しか使えない。

When a patient refuses treatment, the doctor should not use (a) to change his mind. Instead, the doctor should try to understand the (b) and values behind the refusal. Family members' requests come from (c), but the final choice belongs to a patient who is (d) of deciding. If the patient still refuses, the doctor's job changes to (e) the patient's chosen way of life.

(A) capable
(B) pressure
(C) supporting
(D) fears
(E) love
(F) ignoring
(G) research
(H) unable

問2 下線部①のように娘が医師に頼んだ理由と、下線部②の考えに照らしてその頼みに応じることの問題点を、100字以内の日本語で述べよ。

問3 下線部③の内容を、文章1の原さんの場合に当てはめて具体的に説明せよ。下線部④にも触れること。

問4 文章1のような場面で、あなたが医師であれば、原さんと娘さんにそれぞれどのように関わるか。文章2の見解に対するあなた自身の評価も含めて、300字以内の日本語で述べよ。

解答用紙　問題1

愛媛大学 総合問題（英文） 予想問題 第1回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1

問2

（60字以内）

問3

（100字以内）

問4

問5

（80字以内）

問6

（240字以内）

小計（　　）点

解答用紙　問題2

愛媛大学 総合問題（英文） 予想問題 第1回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1（a）

問1（b）

問1（c）

問1（d）

問1（e）

問2

（100字以内）

問3

問4

（300字以内）

小計（　　）点

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 愛媛大学 前期日程 対策 第1回（問題）
想定	愛媛大学　医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）
構成	問題1 医療・科学の英文（抜き出し・字数制限つき説明・和訳・意見）100点／問題2 臨床の状況文と意見文（考察・論述）100点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。

予想問題　第1回

総合問題

医学科

解答・解説

愛媛大学 前期日程 対策

医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）

試験時間 120 分　／　200 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

解答例は一例です。記述問題は、同じ内容が正しく書けていれば別の表現でも得点できます。
各設問の「解説」で、本文のどこを根拠にするかを示しています。全訳・重要語句も確認しましょう。
論述問題は「出題の意図」と「採点の観点」を示しています。

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

問題1　医療・科学の英文　解答・解説　（配点 100 点）

設問	解答（例）	配点
問1	hip replacements / cancer treatments / a difficult childbirth など	9
問2	抗菌薬を使うたびに遺伝子の差で生き残った細菌が増え、薬への耐性を子孫に伝えるので、細菌がその使用から学んで適応していくから。	12
問3	こうした判断の一つ一つはそれだけでは無害に思えるかもしれないが、積み重なると、特定の患者や医師のものではなく、まだ生まれていない人々も含めた皆のものである道具を、少しずつ弱めていく。	16
問4	新しい抗菌薬は耐性菌の広がりを防ぐため、切り札として温存され、できるだけ使われないようにされる。そのため社会にとって価値が高い薬ほど販売量が少なく、開発に多額の費用と時間がかかるのに製薬会社は利益を見込めないから。	15
問5	感染が細菌性かを数分で調べる迅速検査や、軽症では処方を数日待つ方針により、患者に害を与えず不要な処方が減り、市民の理解が新技術と同じく重要だとわかった。	14
問6	解答例は解説欄参照	34

▌解説

問1　第1段落の具体例から3つ。「かつて死因となった感染症」（scratch, pneumonia, childbirth）と「感染の危険がある手術」（hip replacements, cancer treatments）のいずれも可。各3点。

問2　「生き残り」「増殖」「耐性の継承」の3要素（自然選択）を60字以内にまとめる。the bacteria are the ones learning from it「学ぶのは細菌の側だ」の意味も押さえる。

問3　these decisions＝不要な抗菌薬を求める患者・応じる医師の判断。on its own「それ単独では」、not A but B「AではなくB」、including people not yet born「まだ生まれていない人々も含め」。

問4　「温存＝使用量が少ない」→「売れない」→「開発費を回収できない」の因果を書く。the more …, the less … の構文の意味も示す。

問5　取り組み2つ（迅速検査・処方を待つ方針）と結果（害なく不要処方が減少）、教訓（市民の理解の重要性）を80字以内で。

問6　【出題の意図】本文の「抗菌薬は皆の共有資源」という考えを理解したうえで、個々の患者の希望と社会全体の利益の間でどう行動するかを具体的に考えさせる。
【採点の観点】①患者側の事情（症状のつらさ・安心感・時間の制約など）に触れている ②本文の内容（ウイルスには効かない・耐性菌・共有資源）をふまえている ③具体的な対応（説明・検査・経過観察・再受診の目安）が示されている ④字数・表現の適切さ。
【注意】「絶対に出さない」と突き放すだけ、あるいは「求められれば出す」だけの解答は評価が低い。

▌全訳

【抗菌薬――使い尽くしつつある共有資源】1940年代に抗菌薬が導入されたとき、医療はほとんど一夜にして変わった。かつて若く健康な人の命を奪っていた感染症――化膿したかすり傷、肺炎、難産――が、突然数日で治せるようになった。人工股関節置換術やがん治療のように、体を感染の危険にさらす治療も、はるかに安全になった。(①) 直接的にせよ間接的にせよ、これらの薬に頼っていない現代医療の分野を一つでも思い浮かべるのは難しい。

しかし細菌は生き物であり、生き物は適応する。抗菌薬を使うたびに、標的となる細菌のほとんどは死ぬが、遺伝子のわずかな違いのために生き残るものもいる。生き残った菌は増殖し、その子孫は薬に抵抗する同じ能力を受

け継ぐ。(②) この意味で、抗菌薬の1回1回の投与は進化の小さな実験でもあり、そこから学んでいるのは細菌の方なのだ。

抗菌薬が頻繁に使われるほど、耐性は速く広がる。処方の多くは、風邪やほとんどののどの痛みのように、ウイルスが原因で抗菌薬がまったく効かない病気に対して出されている。患者は何か手を打ってもらっていると感じたくて抗菌薬を求めることがあり、忙しい医師は時間を節約するために応じることがある。(③) こうした判断の一つ一つはそれだけでは無害に思えるかもしれないが、合わさると、特定の患者や医師ではなく、まだ生まれていない人々を含む皆のものである道具を、ゆっくりと弱めていく。

その影響はすでに目に見えている。多くの病院で、医師は今や、残された1〜2種類の薬にしか反応しない感染症、ときにはどの薬にも反応しない感染症に出会っている。新しい抗菌薬の開発は時間も費用もかかり、しかも新薬は温存されてできるだけ使われないため、企業には投資する経済的な理由がほとんどない。(④) こうして異例の状況が生まれる。新しい抗菌薬が社会にとって価値があるほど、それを作る会社にとっては利益が少なくなるかもしれないのだ。

そこで保健当局は「適正使用」を強調している。本当に必要なときだけ抗菌薬を使い、適切な薬を適切な期間だけ選び、そもそもワクチン接種や衛生によって感染を防ぐことである。数分で感染が細菌性かどうかがわかる迅速検査や、軽い症状では数日待ってから処方するという方針など、簡単な対策を導入した診療所もある。(⑤) こうした対策は患者に害を与えることなく不要な処方を減らし、市民の理解が新しい技術と同じくらい重要であることを示した。

重要語句

overnight　一夜にして
infection　感染（症）
adapt　適応する
multiply　増殖する
descendant　子孫
inherit　受け継ぐ
resist　抵抗する
dose　（1回分の）投与
prescription　処方
consequence　結果、影響
in reserve　温存して
profitable　利益になる
hygiene　衛生
rapid test　迅速検査
bacterial　細菌性の

問題2　臨床の状況と専門家の見解　解答・解説　（配点 100 点）

設問	解答（例）	配点
問1	(a)B (b)D (c)E (d)A (e)C	20
問2	父が山奥で一人きりで亡くなることに耐えられず、医師の言葉なら従うと考えたから。しかし圧力で得た決定は、医学的に良い結果でも本人の決定とは言えず、自己決定を損なう。	18
問3	原さんにいきなり入院を勧めるのではなく、まず「病院について何を心配しているのか」「家での暮らしの何を大切にしているのか」を尋ね、入院すれば戻れないという恐れの背景を理解する。そのうえで、入院が想像より短く済む可能性や、看護師の訪問など自宅でできる別の方法を示す。それでも本人が自宅を選んだ場合は、説得から支援へと役割を切りかえ、選んだ生活ができるだけ安全で快適に送れるよう手助けする。	20
問4	解答例は解説欄参照	42

▌解説

問1　(a) 文章2第1段落 a decision obtained through pressure。(b) what he values, what he fears（values と並ぶ名詞）。(c) an expression of love and anxiety。(d) be capable of doing「～できる」（able to decide の言いかえ）。(e) It shifts from persuading him to supporting him。各4点。

問2　理由（一人で死なせたくない・父は医師に従う）と問題点（圧力による決定は本人の決定ではない＝自己決定の尊重に反する）の両方を100字以内で。

問3　「勧める前に尋ねる」（価値・恐れ・知識の把握）8点、代替案の提示 6点、④の「説得から支援へ」6点。

問4　【出題の意図】患者の自己決定権と、健康を守る医師の責務、家族の思いが対立する場面で、医療者としてどう行動するかを、文章2を批判的に読んだうえで具体的に述べさせる。
【採点の観点】①文章2への評価（賛否と理由）が明確 ②原さん・娘さんそれぞれへの関わり方が具体的 ③自己決定の尊重と安全の確保のバランスへの配慮 ④判断能力・地域資源など多面的な視点 ⑤字数・論理構成・表現。
【加点要素】意思決定能力の評価、事前の話し合い（アドバンス・ケア・プランニング）、多職種・地域との連携に触れている。

▌全訳

【文章1】84歳の原さんは、妻を亡くしてから小さな山村で一人暮らしをしている。心不全があり、この1年でゆっくり歩いても息切れするようになった。今日の受診で、状態ははっきり悪化している。あなたは、薬を調整するために1時間ほど離れた市内の病院に短期間入院すれば、原さんのためになると考える。そう説明すると、原さんは首を振る。「入院した年寄りがどうなるか知っています」と彼は言う。「帰って来ないんです。たとえ命が短くなっても、自分の家にいたい」。市内に住み、今日付き添ってきた娘があなたをそっと脇へ呼ぶ。「お願いです」と彼女は小声で言う。「(①) ほかに道はないと父に言ってください。父はお医者さんの言うことなら聞きます。父があんな山の上で一人で死ぬなんて、考えるだけで耐えられません」。

【文章2】このような場面で、医師は患者の健康を守る義務と、患者の希望を尊重する義務という二つの義務の板ばさみになりがちだ。患者や家族が医師に与える権威を使って対立を収めたくなることもある。(②) しかし、圧力によって得られた決定は、たとえ医学的にうまくいったとしても、本当の意味で患者の決定ではない。

自己決定を尊重するとは、患者が最初に口にした答えをただ受け入れることではない。原さんの拒否は、病院は終わりを意味するという、正確ではないかもしれない恐れに一部基づいている。医師の最初の仕事は、言葉の背後にあるもの――彼が何を大切にし、何を恐れ、何を知っているのか――を理解することだ。入院は彼が思うより短

くて済むかもしれないし、代わりに看護師が自宅を訪問できるかもしれない。(③) よい医療は、しばしば勧めることではなく、尋ねることから始まる。

娘の頼みにも目を向けるべきだが、それは指示としてではなく、愛情と不安の表れとして理解すべきである。家族は話し合いに加わることができるが、自分で決められる患者の最終的な選択は患者のものだ。十分な話し合いの後も原さんが自宅にとどまることを選ぶなら、医師の役割は終わらない。(④) それは彼を説得することから支えることへと移り、彼が選んだ暮らしをできるだけ安全で快適に送れるようにするのである。

重要語句

heart failure　心不全
short of breath　息切れして
adjust　調整する
take ~ aside　～を脇へ呼ぶ
bear　耐える
duty　義務
tempting　心ひかれる
authority　権威
autonomy　自己決定（権）、自律
refusal　拒否
recommendation　勧め、推奨
deserve　～に値する
anxiety　不安
persuade　説得する

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 愛媛大学 前期日程 対策 第1回（解答・解説）
想定	愛媛大学　医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）
構成	問題1 医療・科学の英文（抜き出し・字数制限つき説明・和訳・意見）100点／問題2 臨床の状況文と意見文（考察・論述）100点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。